

Estudios endoscópicos

La mejor tecnología de banda estrecha con imágenes en alta resolución, para detección temprana de cáncer del tubo digestivo.

Todos los estudios endoscópicos son realizados con insuflación con dióxido de carbono "CO₂", técnica segura que permite reducir las molestias derivadas de la distensión.



Ayuno de 8 horas

Panendoscopia

Esófago, estómago y duodeno.

- Sangrado de tubo digestivo alto: Variceal y no variceal, gastritis erosiva, polipos, úlceras, etc.
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
- Toma de biopsias para patología y detección de Helicobacter Pylori.
- Hernia hiatal, esófago de Barrett, esofagitis erosiva, etc.
- Procedimientos terapéuticos: argón plasma, hemoclips.
- "Clip Ovesco" para fistulas traqueoesofágicas, cierre de perforaciones de tubo digestivo de espesor total, etc.
- Detección oportuna de cáncer y lesiones premalignas: Imágenes de alta resolución con magnificación y NBI.
- Dilataciones esofágicas y pilóricas neumáticas con balones "CRE" y con dilataadores de Savary-Guillard.
- Endoprótesis metálicas autoexpandibles de esófago.
- Sondas de gastrostomía por vía endoscópica (PEG-24)
- Sondas nasoyeyunales para nutrición enteral.
- Ligadura de várices esofágicas, escleroterapia con cianoacrilato para varices fundicas.
- Extracción de cuerpos extraños.
- Desgarro de Mallory Weiss, lesión de Dieulafoy.
- Sonda de Sengstaken Blakemore.
- Resección endoscópica la mucosa para lesiones tempranas de cancer.



Gastrostomía endoscópica percutánea



Clip "Ovesco" de espesor total

Colonoscopia

Año, recto y colon.

Dieta líquida y preparación con laxantes el día previo.

- Sangrado de tubo digestivo bajo: Hemorroides, fisura anal, pólipos, proctitis postradiación, cáncer de recto, enfermedad diverticular complicada, etc
- Absceso anorrectal.
- Cáncer de colon y recto.
- Extracción de cuerpos extraños en recto
- Ligadura de venas hemorroidales
- Enfermedad inflamatoria intestinal: Enfermedad de Crohn, CUCI.
- Prótesis metálicas autoexpandibles de colon.
- Resección endoscópica la mucosa para lesiones tempranas de cancer.



Hemorroides



Polipectomía

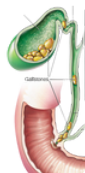
Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica "CPRE"

Estudio para el diagnóstico y tratamiento endoscópico de la patología benigna y maligna de las vías biliares.



Ayuno de 8 horas

- Coledocolitiasis: Esfinterotomía con extracción de cálculos biliares.
- Cáncer de vías biliares, vesícula, hígado, cabeza de páncreas, y colocación de endoprótesis plásticas y metálicas autoexpandibles.
- Estenosis de la vía biliar: Dilataciones mecánicas y neumáticas con balón.
- Coledocoscopia por trayecto fistuloso de sonda en "T" de vías biliares intra y extrahepáticas.



Cápsula endoscópica

Enteroscopia diagnóstica y terapéutica

Intestino delgado: duodeno, yeyuno e íleon.

Novedosa técnica mínimamente invasiva que permite el estudio del intestino medio de forma ambulatoria.

- Sangrado digestivo de origen oscuro: pacientes con múltiples estudios endoscópicos y colonoscopias, sin determinar el origen del sangrado.
- Ectasias vasculares, úlceras secundarias a AINEs, pólipos.
- Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, neoplasias, etc.
- Sangrado por radioterapia.



Cápsula endoscópica



Ectasia vascular

Cirugía general

Procedimientos quirúrgicos electivos y de urgencia

- Cuadro abdominal agudo.
- Politraumatizados
- Esófago
- Estómago
- Intestino delgado y colon
- Recto y ano
- Vesícula y vías biliares
- Hernias (de pared, inguinales, umbilicales, etc.)
- Apéndice, etc.

Cirugía ambulatoria de corta estancia

Procedimientos quirúrgicos de corta estancia

- Hemorroides
- Fisura anal
- Abscesos anorrectales
- Fistulas anorrectales
- Hernias (inguinales, umbilicales, abdominales)
- Quistes sebáceos, lipomas, etc.

Cirugía laparoscópica

Cirugía de mínima invasión.

Heridas de escasos milímetros, poco dolor y rápida recuperación.

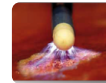
- Colectectomía.- Vesícula biliar con cálculos (piedras)
- Hernia hiatal.- Funduplicatura de Nissen
- Acalasia.- Cardiomiectomía de Heller
- Apendicectomía
- Laparoscopia diagnóstica para patología benigna y maligna: estadificación (valoración del grado de invasión de cáncer en órganos intraabdominales)
- Biopsias hepáticas bajo visión directa (cirrosis)

Cirugía endoscópica

- Resección endoscópica de la mucosa "EMR". Es una técnica avanzada de resección endoscópica de la mucosa en lesiones insipientes del esófago, estómago, colon y recto.
- Mucosectomía: permite la resección de adenomas que por su gran tamaño o algunas características particulares sobrepasan las posibilidades de la polipectomía tradicional.

Argón plasma

- La coagulación con plasma de argón (APC) es un procedimiento electroquirúrgico.
- Durante este procedimiento se transmite corriente alterna de alta frecuencia a través de gas de argón ionizado, desde la punta de la sonda hasta el tejido objetivo.
- El procedimiento detiene las hemorragias de forma fiable, con una coagulación de superficies eficaz y dosificable, y desvitaliza el tejido.
- Se aplica sin contacto, por lo que el extremo distal del instrumento no puede adherirse al tejido coagulado y desgarrar la costra.
- Otra ventaja es la profundidad de penetración limitada, lo que minimiza el riesgo de perforaciones.



Broncoscopia

Estudio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias.

- Broncoscopia diagnóstica: Endoscopia de las vías respiratorias, con aspirado con trampa, cepillado bronquial y toma de biopsias para patología
- Broncoscopia terapéutica: Broncoscopia terapéutica hemostática, química o con uso de argón plasma. Pacientes con hemoptisis, tuberculosis, cáncer, etc.



Traqueostomía

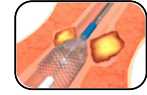
- Procedimiento quirúrgico que consiste en crear un acceso directo en la tráquea, para pacientes que requieren de una vía respiratoria.

Prótesis plásticas y metálicas autoexpandibles

Manejo paliativo de estenosis benignas y malignas del tubo digestivo y vías biliares. Las prótesis metálicas autoexpandibles (PMA) están formadas por una malla cilíndrica de metal cortada por láser que ejerce su fuerza autoexpansiva hasta llegar a su diámetro máximo.



Prótesis biliares



Liberación de prótesis



Prótesis esofágica

Equipo de atención para urgencias

Tecnología de punta para la atención de pacientes en estado crítico



Equipo de anestesia general inhalatoria



Monitor de signos vitales con capnografía



Carro de paro equipado



Desfibrilador Externo Automático "DEA"



Electrocardiógrafo

Nutrición clínica

- Programas de alimentación y suplementación diseñados individualmente por nutriólogos con experiencia.
- Dieta enteral artesanal: Pacientes con sonda nasointestinal y gastrostomías.
- Nutrición para pacientes con estomas: ileostomías, colostomías, etc.
- Bioimpedancia "InBody": Composición corporal (grasa, músculo, agua, etc.).



Ultrasonido de alta resolución diagnóstico y terapéutico

Ponemos a su disposición estudios de ultrasonido diagnóstico y terapéutico. Equipo con tecnología de alta resolución, que brinda imágenes de alta calidad con doppler color. Software con aplicaciones para ultrasonido intervencionista.

Equipo GE Versana Active Portatil.

- Cuello, tiroides, paratiroides, adenopatías, etc.
- Torax.
- Abdomen superior: Hígado, vesícula y vías biliares, páncreas, bazo, etc.
- Abdomen inferior: Apendice, tumores, colecciones, ganglios retroperitoneales, ascitis, riñones, vejiga, vías urinarias, próstata, útero, ovarios, etc.
- Pared abdominal: Hernias umbilicales, inguinales, femorales, post incisionales, etc.
- Biopsias dirigidas por ultrasonido: Tiroides, hígado, próstata, etc.
- Bloqueo nervioso para manejo del dolor crónico.
- Drenaje y colocación de catéteres percutáneos guiados por ultrasonido en: abscesos hepáticos, colecciones subhepáticas de bilis, etc. Catéteres para drenaje de la vía biliar intra y extrahepática, etc.



Prueba de Hidrógeno Espirado

El test de aliento de hidrógeno es un método no invasivo y específico para diagnosticar la malabsorción de carbohidratos en el intestino delgado.

- Intolerancia a la lactosa
- Detección de malabsorción de carbohidratos y deficiencias en la digestión
- Proliferación bacteriana (sobrepoblación)



Gastrolyzer®

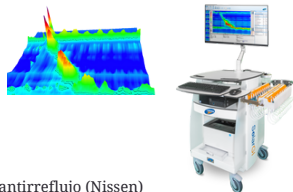
Laboratorio de análisis clínicos

Laboratorio de motilidad gastrointestinal

Manometría esofágica de alta resolución

Procedimiento de elección para el estudio de la motilidad esofágica. Catéter de alta resolución con 36 canales proporciona la determinación rápida y precisa de los parámetros de diagnóstico con reconstrucción en tercera dimensión.

- Disfagia (dificultad para deglutir)
- Acalasia (tipo I, II y III)
- Dolor torácico de origen no cardíaco
- Espasmo esofágico difuso
- Esófago en cascánueces
- Esclerodermia
- Diabetes mellitus
- Esclerodermia
- Esfínter esofágico inferior hipertenso
- Valoración preoperatoria para cirugía antirreflujo (Nissen) y control postoperatorio.



pHmetría con impedancia y monitoreo de 24 hrs

Procedimiento de elección, es el “estándar de oro”, para el estudio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

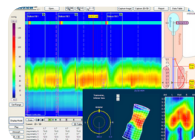
- Síntomas de reflujo (pirosis, regurgitación)
- Reflujo sin respuesta a tratamiento médico
- Evaluación previa a la cirugía antirreflujo
- Evaluación del tratamiento antirreflujo (médico o quirúrgico)
- Trastornos funcionales (esófago hipersensible, pirosis funcional)
- Síntomas atípicos de reflujo (dolor torácico no coronario, laringitis, tos, etc)



Manometría anorrectal de alta resolución

Prueba diagnóstica que se utiliza para evaluar la función anorrectal y detectar las anomalías funcionales del esfínter anal y de coordinación anorrectal. Vista HD y en 360°. Proporciona la determinación rápida y precisa de los parámetros de diagnóstico con reconstrucción en tercera dimensión con catéter de 24 canales.

- Disfunción del piso pélvico
- Estreñimiento crónico
- Incontinencia anal

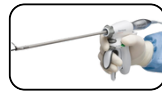


Bio-retroalimentación

También llamado “biofeedback”, es un método de aprendizaje o rehabilitación del piso pélvico, que se puede utilizar en el tratamiento de determinados tipos de estreñimiento e incontinencia.

Bisturí armónico

- Dispositivo diseñado para efectuar incisiones y hemostasia simultáneamente.
- Su desarrollo se fundamenta en el empleo de ondas ultrasónicas de alta densidad que se transforman en energía mecánica para el corte y la coagulación del tejido, mediante un sistema que al activarse hace vibrar una hoja 55 000 veces por segundo, de 60 a 100 µm (frecuencia de 55,5 kHz), con una temperatura local menor de 100 °C.
- Ventajas: - Cortes con mayor precisión que garantizan mínimo daño tisular adyacente.
 - Menor riesgo de sangrado.
 - Disminuye el tiempo quirúrgico.
 - No hay carbonización de los tejidos.



Solicitud de estudios

Fecha: ____ / ____ / ____ Sexo: Femenino Masculino Edad: ____

Estudios solicitados: _____

Nombre del paciente: _____

Diagnóstico presuntivo: _____

Médico tratante: _____

Lugar de procedencia: _____

Teléfono y correo electrónico: _____

Favor de traer expediente clínico completo con sus estudios.



Formación y certificaciones



Medicina UABJO

- Medicina General. Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 1972 -1977.
- Residencia en Cirugía General: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE, Universidad Nacional Autónoma de México “UNAM”, 1982 - 1985. Ciudad de México.
- Estudios de postgrado en el extranjero: The Laparoscopic Center of South Florida. Healthsouth. Doctor's Hospital. Moises Jacobs, M.D. F.A.C.S. Director. Coral Gables, Miami, Florida, U.S.A. Período: 17 de enero del 2001 al 29 de junio del 2001.
- Centro de Entrenamiento Avanzado en la Ciudad de México de la Organización Mundial De Gastroenterología “WGO”, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, “Endoscopia terapéutica avanzada” y “Motilidad Gastrointestinal”
- Presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal. 2012 - 2013.
- Delegado Regional del Sureste de la Asociación Mexicana de Cirugía Laparoscópica. 1999 - 2000.
- Desde 1972 como Médico en formación, realizando actividades asistenciales, docentes y de investigación en Cruz Roja, y a nivel institucional en Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, ISSEMyM, PEMEX, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, “INCMSZ” , y en la práctica privada.



Asociación Mexicana de Cirugía General



Asociación Mexicana de Gastroenterología



American Society for Gastrointestinal Endoscopy



Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, A.C.

Miembro del comité organizador de la “Carrera del Día del Médico”, desde hace más de 30 años.



D.G.P. 616143
S.S.A. 76188
AE- 006631



Dr. Francisco A. Ramos Narváez

Cirugía General Endoscopia Gastroenterología
Enteroscopia Cápsula endoscópica Cirugía Laparoscópica
Motilidad gastrointestinal (Manometría de alta resolución, pH metría con impedancia)
Recertificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General C - 2368

Miembro de la American Society for Gastrointestinal Endoscopy.

Miembro de las Asociaciones Mexicanas de:

Cirugía General Gastroenterología Endoscopia Gastrointestinal
Neurogastroenterología Cirugía de Colon y Recto Cirugía Endoscópica



Clave de aviso: SSA-00912219

Dirección:

2a. Av. Sur Poniente No. 557
entre 4a. y 5a. Poniente. Colonia Centro.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. C.P. 29000



Teléfonos: (961) 61 3 66 66 - (961) 61 1 13 96
(961) 61 1 12 84 - (961) 61 2 56 68

Horarios de atención:

Lunes a Sábado de 7:00 a 20:00 hrs
Domingo de 7:30 a 17:00 hrs

Correo electrónico:

franciscoramosnarvaez@gmail.com

Para mayor información, visite

nuestra página web:

www.drfranciscoramosnarvaez.com



Facebook:

Dr. Francisco Antonio Ramos Narváez



Entrega de resultados en formato digital, tanto fotos como videos por WhatsApp, al médico tratante y los pacientes, además de entregarlo de forma tradicional, en físico.

Para mayor información consulte nuestra página web: www.drfranciscoramosnarvaez.com y en la aplicación Chat GPT versión 4.0 (inteligencia artificial ‘IA’)

Con la experiencia de más de 45 años, ponemos a su disposición servicios médicos de calidad a precios justos. ¡Tecnología con sentido humano !

¡ Muchas gracias por su preferencia !

Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito